



Lignes directrices de l'OMS sur la prise en charge clinique de la maladie à filovirus

Résumé d'orientation



Organisation
mondiale de la Santé

Lignes directrices de l'OMS sur la prise en charge clinique de la maladie à filovirus

Résumé d'orientation



Organisation
mondiale de la Santé

Certains droits réservés. La présente œuvre est disponible sous la licence Creative Commons Attribution – Pas d'utilisation commerciale – Partage dans les mêmes conditions 3.0 IGO (CC BY-NC-SA 3.0 IGO ; <https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/igo/deed.fr>).

Aux termes de cette licence, vous pouvez copier, distribuer et adapter l'œuvre à des fins non commerciales, pour autant que l'œuvre soit citée de manière appropriée, comme il est indiqué cidessous. Dans l'utilisation qui sera faite de l'œuvre, quelle qu'elle soit, il ne devra pas être suggéré que l'OMS approuve une organisation, des produits ou des services particuliers. L'utilisation du logo de l'OMS est interdite. Si vous adaptez cette œuvre, vous êtes tenu de diffuser toute nouvelle œuvre sous la même licence Creative Commons ou sous une licence équivalente. Si vous traduisez cette œuvre, il vous est demandé d'ajouter la clause de non-responsabilité suivante à la citation suggérée : « La présente traduction n'a pas été établie par l'Organisation mondiale de la Santé (OMS). L'OMS ne saurait être tenue pour responsable du contenu ou de l'exactitude de la présente traduction. L'édition originale anglaise est l'édition authentique qui fait foi ».

Toute médiation relative à un différend survenu dans le cadre de la licence sera menée conformément au Règlement de médiation de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (<https://www.wipo.int/amc/fr/mediation/rules/index.html>).

Citation suggérée. Lignes directrices de l'OMS sur la prise en charge clinique de la maladie à filovirus: résumé d'orientation [WHO guidelines for the clinical management of filovirus disease: executive summary]. Genève, Organisation mondiale de la Santé, 2026. <https://doi.org/10.2471/B09810>. Licence : CC BY-NC-SA 3.0 IGO.

Catalogage à la source. Disponible à l'adresse <https://iris.who.int/?locale-attribute=fr&>

Ventes, droits et licences. Pour acheter les publications de l'OMS, voir <https://www.who.int/publications/book-orders>. Pour soumettre une demande en vue d'un usage commercial ou une demande concernant les droits et licences, voir <https://www.who.int/fr/copyright>

Matériel attribué à des tiers. Si vous souhaitez réutiliser du matériel figurant dans la présente œuvre qui est attribué à un tiers, tel que des tableaux, figures ou images, il vous appartient de déterminer si une permission doit être obtenue pour un tel usage et d'obtenir cette permission du titulaire du droit d'auteur. L'utilisateur s'expose seul au risque de plaintes résultant d'une infraction au droit d'auteur dont est titulaire un tiers sur un élément de la présente œuvre.

Clause générale de non-responsabilité. Les appellations employées dans la présente publication et la présentation des données qui y figurent n'impliquent de la part de l'OMS aucune prise de position quant au statut juridique des pays, territoires, villes ou zones, ou de leurs autorités, ni quant au tracé de leurs frontières ou limites. Les traits discontinus formés d'une succession de points ou de tirets sur les cartes représentent des frontières approximatives dont le tracé peut ne pas avoir fait l'objet d'un accord définitif.

La mention de firmes et de produits commerciaux ne signifie pas que ces firmes et ces produits commerciaux sont agréés ou recommandés par l'OMS, de préférence à d'autres de nature analogue. Sauf erreur ou omission, une majuscule initiale indique qu'il s'agit d'un nom déposé.

L'OMS a pris toutes les précautions raisonnables pour vérifier les informations contenues dans la présente publication. Toutefois, le matériel publié est diffusé sans aucune garantie, expresse ou implicite. La responsabilité de l'interprétation et de l'utilisation dudit matériel incombe au lecteur. En aucun cas, l'OMS ne saurait être tenue pour responsable des préjudices subis du fait de son utilisation.

Conception et mise en page par L'IV Com Sàrl.

Résumé d'orientation

Remarque

Le présent document constitue un résumé des lignes directrices. Pour consulter le texte intégral et les références bibliographiques, voir le texte en anglais <https://doi.org/10.2471/B09774>. La version anglaise est également disponible dans un format interactif à l'adresse : <https://app.magicapp.org/#/guideline/11037>.

Sigles

EIG	événements indésirables graves
GDG	groupe d'élaboration des lignes directrices
OMS	Organisation mondiale de la Santé

Question clinique: Quelles sont les interventions susceptibles d'améliorer les résultats pour les patientes et patients face à la maladie à filovirus ?

Justification et portée

La maladie à filovirus englobe les infections causées par les virus Bundibugyo, Ebola, Marburg, Soudan et Tai Forest. Les lignes directrices précédentes de l'OMS étaient axées sur la maladie à virus Ebola et reposaient sur les meilleures pratiques cliniques définies par des spécialistes. Les présentes lignes directrices élargissent le champ d'application à tous les filovirus afin de réduire les redondances, d'harmoniser les approches et d'optimiser les effets pour l'ensemble des flambées épidémiques. Des recommandations ont également été formulées à partir d'informations issues de recherches systématiques de données probantes, et selon l'approche GRADE (*Grading of Recommendations Assessment, Development and Evaluation*) afin de maximiser la transparence et de garantir que les considérations de mise en œuvre ont été soigneusement évaluées.

Méthodes

Les lignes directrices ont été élaborées conformément au *manuel de l'OMS pour l'élaboration de lignes directrices*. Un groupe d'élaboration des lignes directrices (GDG) a été constitué, avec des représentantes et représentants de disciplines cliniques, régions et genres divers. Tous les membres ont rempli des formulaires de déclaration d'intérêts, qui ont été examinés et traités selon les procédures standard de l'OMS.

Les questions cliniques ont été formulées selon le format PICO (Population, Intervention, Comparaison/Comparateur, critère de jugement ou issue clinique [O pour outcome, en anglais]). La synthèse des données probantes s'est principalement appuyée sur des revues systématiques récentes de haute qualité. L'approche GRADE a été utilisée pour établir le degré de certitude des données probantes et définir à la fois la valence et la force des recommandations. Pour chaque recommandation, un cadre des données probantes à l'appui de la prise de décision (*evidence-to-decision*) a été appliqué, comprenant : le bilan des avantages et des inconvénients ; le degré de certitude des données probantes ; les valeurs et préférences des patientes et patients ; la faisabilité ; l'utilisation des ressources ; l'équité ; l'acceptabilité.

Les recommandations provisoires ont fait l'objet d'un examen collégial interne et externe et d'une approbation finale par le Comité d'examen des lignes directrices de l'OMS.

Principales recommandations

- Pour les patientes et patients présentant une maladie à filovirus suspectée ou confirmée, il convient d'instaurer une surveillance systématique au moyen d'une évaluation clinique structurée et documentée, à intervalles réguliers, la fréquence étant adaptée à l'état de la personne (énoncé de bonnes pratiques).
- Pour les patientes et patients présentant une maladie à filovirus suspectée ou confirmée, l'OMS recommande d'effectuer une surveillance biologique systématique sur la base d'une évaluation clinique, plutôt que sur des tests de routine (recommandation forte en faveur de l'intervention – degré de certitude des données probantes : faible).
- Pour les patientes et patients présentant une maladie à filovirus suspectée ou confirmée, avec des pertes continues de liquide gastro-intestinal et des signes de déshydratation modérée, l'OMS recommande un protocole de réhydratation orale (par exemple, Plan B de l'OMS) (recommandation forte en faveur de l'intervention – degré de certitude des données probantes : modéré).
- Pour les patientes et patients présentant une maladie à filovirus suspectée ou confirmée, avec des pertes continues de liquide gastro-intestinal et des signes de déshydratation sévère, l'OMS propose un protocole d'apport liquidien par perfusion intraveineuse plutôt que l'absence de protocole de perfusion (recommandation conditionnelle en faveur de l'intervention – degré de certitude des données probantes : faible).

- Pour les patientes et patients présentant une maladie à filovirus suspectée ou confirmée, l'OMS recommande l'utilisation de cristalloïdes équilibrés (comme le Ringer lactate) plutôt que du chlorure de sodium à 0,9 % pour la réanimation liquidienne intraveineuse (recommandation forte en faveur de l'intervention – degré de certitude des données probantes : modéré).
- Pour les patientes et patients présentant une maladie à filovirus suspectée ou confirmée et des signes cliniques de choc ou de trouble circulatoire, l'OMS propose la mesure en série du lactate, dans le cadre de l'évaluation de la perfusion, en vue d'affiner la prise en charge par voie intraveineuse (recommandation conditionnelle en faveur de l'intervention – degré de certitude des données probantes : faible).
- Pour les patientes et patients présentant une maladie à filovirus suspectée ou confirmée et des signes cliniques de choc ou de trouble circulatoire, l'OMS conseille d'utiliser le temps de recoloration capillaire, dans le cadre de l'évaluation de la perfusion, en vue d'orienter la prise en charge par voie intraveineuse (recommandation conditionnelle en faveur de l'intervention – degré de certitude des données probantes : faible).
- Pour les patientes et patients présentant une maladie à filovirus suspectée ou confirmée, en état de choc et bénéficiant d'un remplissage vasculaire, l'OMS conseille la mise en place précoce d'un traitement vasopresseur plutôt qu'une mise en place tardive (recommandation conditionnelle en faveur de l'intervention – degré de certitude des données probantes : faible).
- Pour les patientes et patients qui présentent une maladie à filovirus suspectée ou confirmée et qui nécessitent un traitement vasopresseur, l'OMS recommande l'utilisation de la noradrénaline plutôt que de la dopamine (recommandation forte en faveur de l'intervention – degré de certitude des données probantes : modéré).
- Pour les patientes et patients qui présentent une maladie à filovirus suspectée ou confirmée et qui nécessitent un traitement vasopresseur, l'OMS conseille l'utilisation de la noradrénaline plutôt que de l'adrénaline (recommandation conditionnelle en faveur de l'intervention – degré de certitude des données probantes : très faible).
- Pour les patientes et patients atteints de la maladie à filovirus et qui nécessitent l'instauration d'un traitement vasopresseur, l'OMS conseille d'utiliser un cathéter veineux périphérique plutôt qu'un cathéter veineux central (recommandation conditionnelle en faveur de l'intervention – degré de certitude des données probantes : très faible).
- Pour les patientes et patients présentant une maladie à filovirus suspectée ou confirmée, et qui nécessitent la pose d'un accès veineux central, l'OMS recommande une pose par guidage échographique plutôt qu'un autre type de pose (recommandation forte en faveur de l'intervention – degré de certitude des données probantes : modéré).
- Pour les patientes et patients présentant une maladie à filovirus confirmée et en cas de suspicion de sepsis ou de co-infection bactérienne, l'OMS propose l'administration d'un traitement antibiotique présomptif à large spectre (recommandation conditionnelle en faveur de l'intervention – degré de certitude des données probantes : faible).
- L'OMS déconseille l'emploi de l'acide tranexamique chez les patientes et patients présentant une maladie à filovirus confirmée et une hémorragie (recommandation conditionnelle en défaveur de l'intervention – degré de certitude des données probantes : très faible).
- L'OMS conseille l'utilisation de l'acide tranexamique chez les patientes présentant une maladie à filovirus confirmée et une hémorragie du post-partum (recommandation conditionnelle en faveur de l'intervention – degré de certitude des données probantes : faible).
- L'OMS recommande que les personnes qui ont survécu à la maladie à filovirus/qui se sont rétablies de la maladie à filovirus se voient proposer un suivi structuré après la sortie du lieu de soins (recommandation forte en faveur de l'intervention – degré de certitude des données probantes : modéré).

Mise en pratique

Dans le cadre de la maladie à filovirus, des soins de soutien de haute qualité peuvent réduire la mortalité. La disponibilité des ressources, l'environnement sous-optimal dans lequel les soins sont souvent dispensés, le besoin de procédures rigoureuses en matière de lutte anti-infectieuse et la formation limitée du personnel compliquent la mise en œuvre des interventions cliniques. Ces lignes directrices cliniques complètent plusieurs autres documents d'orientation de l'OMS, qui ensemble répondent à ces défis. Dans le cadre de cette approche multidisciplinaire, la mise en œuvre des principes cliniques et la prestation de soins centrés sur la personne permettront de sauver des vies et d'améliorer les résultats pour les patientes et patients.

Énoncé de bonnes pratiques

Pour les patientes et patients présentant une maladie à filovirus suspectée ou confirmée, il convient d'instaurer une surveillance systématique au moyen d'une évaluation clinique structurée et documentée, à intervalles réguliers, la fréquence étant adaptée à l'état de la personne.

- Cet énoncé s'applique à tous les enfants et adultes, y compris aux femmes enceintes.
- Les anomalies identifiées lors d'une évaluation et d'une surveillance doivent être suivies d'une action immédiate, qui devrait améliorer les résultats pour la patiente/le patient.

Le Groupe a souligné à l'unanimité l'importance de la surveillance, laquelle doit être directement reliée aux interventions cliniques, dans le cadre d'une prise de décision individualisée permettant de garantir que les besoins des patientes et patients soient satisfaits. Le Groupe a émis l'hypothèse de la survenue d'événements indésirables à très faible fréquence, liés à la surveillance non invasive, et d'une répercussion négligeable lorsque ceux-ci se produisent. En revanche, le Groupe a envisagé un risque de désavantage catastrophique lorsque la physiologie anormale n'est pas reconnue.

Le Groupe a d'abord pris en compte des données probantes issues d'essais contrôlés randomisés (ECR) de télésurveillance continue, pour lesquelles il a été établi un degré de certitude très faible concernant les critères de mortalité, de complications majeures et de durée de séjour. Cependant, il a estimé qu'elles ne reflétaient pas le véritable rapport avantages-inconvénients d'une surveillance plus large des patientes et patients, car cette modalité n'est pas la méthode attendue pour assurer une surveillance fréquente et intermittente lors des flambées épidémiques de maladie à filovirus.

Il a été considéré que le manque d'essais contrôlés randomisés était dû au manque de principe d'équivalence, compte tenu du principe fondamental de la surveillance appliquée tout au long de la pratique clinique. Le Groupe a discuté de la possibilité de créer un profil de données probantes associées en vue d'étayer une recommandation forte et non discordante. Toutefois, cette action nécessiterait un effort disproportionné. Les membres ont échangé des données expérientielles sur la manière dont la détection précoce des anomalies – si celles-ci sont prises en charge – sauve effectivement des vies. Par ailleurs, un consensus est apparu sur le fait que l'observation des patientes et patients constitue une part fondamentale de la prestation de soins médicaux de haute qualité.

Cette intervention a été appuyée par des considérations d'équité (avantage pour l'ensemble des patientes et patients) et des preuves d'acceptabilité et de faisabilité dans le cadre de la pratique quotidienne. Les besoins en ressources ont été examinés, notamment un personnel et des actions de formation en nombre suffisant. Le niveau de soins exigé à l'échelle du centre de traitement déterminera les besoins absolus en matière de ressources humaines.

Le Groupe a plaidé pour une amélioration de la conception des centres de traitement afin de faciliter la surveillance depuis la zone verte, ainsi que la communication entre la zone verte et la zone rouge.

Il a souligné que l'énoncé de bonnes pratiques présentait la même force qu'une recommandation forte en faveur d'une surveillance systématique des patientes et patients. Le Groupe a rappelé le principe important selon lequel la fréquence de la surveillance doit reposer sur la gravité de la maladie.

Recommandation forte en faveur de l'intervention – degré de certitude des données probantes : faible

Pour les patientes et patients présentant une maladie à filovirus suspectée ou confirmée, l'OMS recommande d'effectuer une surveillance biologique systématique sur la base d'une évaluation clinique, plutôt que sur des tests de routine.

- Cette recommandation s'applique à tous les enfants et adultes, y compris aux femmes enceintes.
- Il convient que la surveillance biologique soit liée à des interventions cliniques concrètes visant à améliorer les résultats pour les patientes et patients. En vue d'éclairer la prise de décision clinique, le délai de traitement des résultats de laboratoire devra être approprié.
- La portée et la fréquence des analyses en laboratoire seront adaptées aux besoins des patientes et patients, conjointement à une utilisation judicieuse des ressources et à une réduction au minimum des ponctions veineuses.
- Il convient que l'ensemble minimal de tests disponibles comprenne les éléments suivants : tests de diagnostic rapide du paludisme sur le lieu de soins, glucose, hémoglobine/hématocrite, numération et formule sanguine, test de grossesse, bandelette urinaire, tests requis pour la transfusion sanguine, électrolytes et biochimie. Des tests supplémentaires peuvent être nécessaires en fonction du niveau de soins.
- La sécurité biologique doit être mise en œuvre à toutes les étapes, y compris durant la collecte des échantillons, le transport, la manipulation en laboratoire et l'élimination des échantillons.

Les données probantes proviennent d'une revue systématique commandée par l'OMS et publiée dans le cadre de ces lignes directrices.

Le Groupe a estimé que la surveillance biologique est un outil qui permet de détecter de manière plus précoce les anomalies physiopathologiques importantes et qui fournit des données essentielles liées à la maladie. En orientant directement l'action clinique, les résultats de laboratoire sont susceptibles d'améliorer l'issue pour les patientes et patients. Le Groupe a donné les exemples de l'hypoglycémie, qui est potentiellement mortelle, et de l'hyperkaliémie, qui est à la fois potentiellement mortelle et impossible à détecter sans analyses en laboratoire. Dans les deux cas, un traitement spécifique peut corriger l'anomalie et réduire ainsi le risque de décès. Parmi d'autres exemples, citons la détection de l'insuffisance rénale ou hépatique pour laquelle des ajustements cliniques de la posologie des médicaments sont nécessaires afin d'éviter une iatrogénie.

L'analyse univariée a démontré un lien évident entre anomalie et mortalité en établissement : pour l'hyperkaliémie, OR 11,11 (IC à 95 % : 2,70-45,66), degré de certitude modéré ; pour la rhabdomyolyse aOR 2,18 (IC à 95 % : 1,09-4,37) ; pour la créatinine aOR 2,3 pour chaque augmentation de 100 mmol/l (IC à 95 % : 1,1-4,6), degré de certitude élevé ; et pour l'hémoglobine aOR 0,67 (IC à 95 % : 0,47-0,93), degré de certitude élevé.

À l'aide de ces données probantes associées, dont le degré de certitude a été jugé globalement faible, le Groupe a formulé une recommandation forte en faveur de la surveillance biologique. Le Groupe a noté que de nombreuses anomalies biochimiques potentiellement mortelles n'avaient pas de bonne corrélation clinique, mais pouvaient être traitées efficacement lorsqu'elles étaient identifiées. Une recommandation discordante était donc justifiée sur la base du risque élevé d'issue catastrophique en cas d'impossibilité de réaliser des analyses en laboratoire.

L'expérience issue des flambées épidémiques de maladie à filovirus les plus récentes a démontré que la surveillance biologique n'était pas la « norme de soins », et pouvait, dans certaines circonstances, être de l'ordre du souhaitable, entraînant un retard de reconnaissance et des résultats défavorables pour les patientes et patients. Le Groupe a indiqué qu'une recommandation forte serait plus susceptible d'améliorer la disponibilité, grâce à l'envoi d'un message clair aux décideurs, aux administrateurs de laboratoires de santé publique et aux administrateurs d'établissements de santé.

Les membres ont répertorié un ensemble essentiel d'analyses de laboratoire qu'il convient de mettre à disposition ; des analyses supplémentaires seront proposées en fonction du niveau de soins fournis au sein du centre de traitement.

Les tests de base comprennent les éléments suivants : sodium (Na⁺) ; potassium (K⁺) ; lactate ; créatinine ; glucose ; numération et formule sanguine (globules rouges, globules blancs, hémoglobine, hématocrite, plaquettes) ; temps de prothrombine/temps de céphaline activée ; test de diagnostic rapide du paludisme ; VIH selon le protocole national ; gonadotrophine chorionique humaine (bHCG) pour le test de grossesse, le groupe sanguin et la compatibilité (aux fins de transfusion) ; analyse d'urine (bandelette urinaire).

Les tests complets comprennent les tests de base plus : urée ; chlorure ; bicarbonate ; calcium ; phosphate ; magnésium ; créatine-kinase ; transaminases hépatiques ; fibrinogène ; plaquettes ; hémoculture ; tests PCR multiplex de détection d'agents pathogènes ; protéine C-réactive. De plus, dans les zones à forte prévalence du VIH, il faut prendre en compte le lipoarabinomannane urinaire et l'antigène cryptococcique chez les patientes et patients vivant avec le VIH.

Recommandation forte en faveur de l'intervention – degré de certitude des données probantes : modéré

Pour les patientes et patients présentant une maladie à filovirus suspectée ou confirmée, avec des pertes continues de liquide gastro-intestinal et des signes de déshydratation modérée^a, l'OMS recommande un protocole de réhydratation orale (par exemple, Plan B de l'OMS).

- Cette recommandation s'applique à la fois aux enfants et aux adultes, y compris aux femmes enceintes.
- Une surveillance systématique des signes vitaux, y compris l'apport et l'élimination de liquides, est nécessaire pour identifier les patientes et patients qui pourraient avoir besoin d'un traitement renforcé par perfusion intraveineuse.
- Chez toutes les personnes atteintes de la maladie à filovirus, il convient de procéder à la pose d'un cathéter veineux périphérique au cas où une administration de solutés par perfusion serait nécessaire.
- Cette recommandation ne s'applique pas aux patientes et patients présentant un sepsis ou un choc septique (pour lesquels un traitement par perfusion intraveineuse est indiqué), ni à ceux souffrant de malnutrition aiguë sévère (pour lesquels d'autres lignes directrices de l'OMS seront utilisées).

^a **Chez l'enfant** : une déshydratation modérée est définie comme l'absence de signes de déshydratation sévère, avec deux ou plusieurs des signes suivants : agitation ; irritabilité ; yeux creux ; assoiffé et boit avidement ; pli cutané persistant. La déshydratation sévère suppose deux ou plusieurs des signes suivants : léthargie ou perte de connaissance ; yeux creux ; incapable de boire ou boit peu ; pli cutané très persistant (≥ 2 secondes).

Chez l'adulte : la déshydratation modérée est moins bien définie que chez l'enfant, mais inclut des symptômes tels que : soif ; urine concentrée ; miction peu fréquente ; sensation d'étourdissement ou de vertige ; fatigue ; bouche, lèvres et langue sèches ; yeux creux.

Les données probantes sont issues de larges cohortes observationnelles en lien avec le choléra, relevées avant et après la mise en œuvre d'un traitement structuré de réhydratation orale (désormais codifié comme Plan B de l'OMS). Le degré de certitude des données probantes a été revu à la hausse en raison de l'effet de grande ampleur. Le Groupe a discuté de l'applicabilité à la maladie à filovirus et a noté qu'en cas de déshydratation modérée, les avantages étaient probablement similaires. Le Groupe a souligné que la plupart des patientes et patients présentant une déshydratation modérée accorderaient une grande importance à des données probantes d'un degré de certitude modéré pour le critère de mortalité, dans le cadre d'un traitement de réhydratation orale (c'est-à-dire le Plan B de l'OMS), surtout lorsque les inconvénients sont insignifiants par rapport aux avantages en matière de mortalité. Le Groupe a reconnu un accroissement de différences importantes sur le plan clinique chez les sujets souffrant de déshydratation sévère et/ou de sepsis et/ou de choc, ou ceux à haut risque de complications liées à l'administration de liquides à haut volume, par exemple ceux présentant une insuffisance cardiaque congestive préexistante ou une malnutrition aiguë sévère.

Il a souligné que cette recommandation ne s'appliquait que lorsque les sujets pouvaient facilement recevoir une réhydratation orale. Il a indiqué que, pour les patientes et patients atteints de la maladie à filovirus et susceptibles de subir une détérioration rapide de leur état clinique, il convient de poser une voie intraveineuse même en cas de réhydratation orale, et de procéder à une surveillance étroite. De même, le Groupe a signalé qu'en cas de sepsis et/ou de choc, un traitement par perfusion intraveineuse est nécessaire.

Recommandation conditionnelle en faveur de l'intervention – degré de certitude des données probantes : faible

Pour les patientes et patients présentant une maladie à filovirus suspectée ou confirmée, avec des pertes continues de liquide gastro-intestinal et des signes de déshydratation sévère^a, l'OMS propose un protocole d'apport liquidien par perfusion intraveineuse plutôt que l'absence de protocole de perfusion.

- Cette recommandation s'applique à la fois aux adultes et aux enfants.
- Une surveillance systématique et fréquente de l'état hémodynamique, de l'apport et de l'élimination de liquides, ainsi que des signes de surcharge hydrique est nécessaire pour doser et personnaliser le traitement.
- Des modifications du Plan C de l'OMS sont nécessaires pour renforcer la surveillance et permettre un protocole d'apport liquidien plus restrictif dans les cas où il est difficile de distinguer une déshydratation sévère et une hypoperfusion induite par un sepsis (voir la section Informations pratiques).
- Une fois la déshydratation corrigée, administrer un apport liquidien d'entretien, en fonction des besoins estimés d'après le poids et les pertes insensibles et continues.
- Chez les sujets en état de choc, il est nécessaire de réévaluer soigneusement l'étiologie de la perturbation afin de procéder à une réanimation appropriée.

^a **Chez l'enfant** : la déshydratation sévère suppose deux ou plusieurs des signes suivants : léthargie ou perte de connaissance ; yeux creux ; incapable de boire ou boit peu ; pli cutané très persistant (≥ 2 secondes).

Chez l'adulte : une déshydratation sévère, nécessitant une réanimation urgente par perfusion intraveineuse de solutés, est caractérisée par l'un des éléments suivants : une tension artérielle systolique inférieure à 100 mmHg ; une fréquence cardiaque supérieure à 90 battements par minute ; un temps de recoloration capillaire supérieur à 2 secondes ; des extrémités froides ; une fréquence respiratoire supérieure à 20 cycles par minute.

Le Groupe a souligné que la majorité des patientes et patients souffrant de déshydratation sévère et de pertes de liquide gastro-intestinal persistantes accorderaient une grande importance aux données probantes d'un degré de certitude faible pour le critère de mortalité, dans le cadre d'un protocole de réhydratation par voie intraveineuse (comme le Plan C) et ont exprimé une vive inquiétude quant aux risques potentiellement graves lorsque des distinctions, sur le plan clinique, entre sepsis et déshydratation sévère sont évidentes dans ces recommandations. Le Groupe a relevé que l'utilisation du Plan C était largement connue auprès des prestataires de santé et de soins qui prennent en charge les sujets souffrant de déshydratation sévère issue d'autres causes et que, par conséquent, un changement de pratique nécessiterait une base factuelle plus solide. Cependant, les modifications apportées au protocole de réhydratation par voie intraveineuse (Plan C modifié, voir Informations pratiques) visent à atténuer les effets préjudiciables et à optimiser l'efficacité chez les populations où le risque de préjudice peut être plus élevé, par exemple les patientes et patients atteints de la maladie à filovirus et d'un sepsis, ainsi que ceux atteints d'autres maladies chroniques prédisposés à la surcharge volémique (insuffisance rénale, insuffisance hépatique, insuffisance cardiaque, etc.).

La recommandation s'applique aux adultes, aux enfants et aux femmes enceintes. Le Groupe a toutefois noté que pour les enfants souffrant de malnutrition aiguë sévère co-existante, d'autres protocoles d'apport liquidien devront être envisagés. Pour les sujets atteints de la maladie à filovirus et d'un sepsis, voir les recommandations suivantes.

Recommandation forte en faveur de l'intervention – degré de certitude des données probantes : modéré

Pour les patientes et patients présentant une maladie à filovirus suspectée ou confirmée, l'OMS recommande l'utilisation de cristalloïdes équilibrés (comme le Ringer lactate) plutôt que du chlorure de sodium à 0,9 % pour la réanimation liquidienne intraveineuse

- Cette recommandation s'applique aux enfants et aux adultes, y compris aux femmes enceintes, qui présentent un sepsis, un choc septique et/ou une déshydratation.
- Parmi les cas où il pourrait être préférable d'utiliser du chlorure de sodium à 0,9 %, notons celui des patientes et patients atteints de la maladie à filovirus et présentant un trauma, y compris une lésion cérébrale traumatique.

Le Groupe a estimé que la majorité des patientes et patients préféreraient un traitement avec une solution équilibrée plutôt qu'avec une solution saline normale, et a relevé qu'ils accorderaient une grande importance aux données probantes d'un degré de certitude modéré pour l'avantage en matière de mortalité (dans le contexte du risque de mortalité de référence 600/1 000, équivalant à -42 pour 1 000, IC à 95 % : -84 à +6). En ce qui concerne les inconvénients, le Groupe a discuté de la prévalence accrue de l'acidose hyperchlorémique, avec le chlorure de sodium à 0,9 % comme mécanisme potentiel. Cependant, il a également noté une possible augmentation des risques lorsque des solutions équilibrées étaient utilisées dans le contexte d'une lésion cérébrale traumatique. Le Groupe a en outre observé que la surveillance des électrolytes chez les sujets atteints de la maladie à filovirus et présentant des vomissements et diarrhées pourrait également influencer sur le choix du soluté intraveineux. Un consensus a été atteint, mais parmi les membres du Groupe, on relève quatre abstentions liées à des circonstances spécifiques dans lesquelles le Ringer lactate pourrait ne pas être supérieur au chlorure de sodium à 0,9 %. Ces éléments ont été consignés dans les remarques relatives à la recommandation, mais ces circonstances devraient être rares lors de la présentation initiale de la maladie à filovirus et n'entraînent donc pas la formulation d'une recommandation conditionnelle.

Compte tenu du manque de données propres au sepsis dans le traitement de suppléance rénale et les jours sans ventilation dans la méta-analyse, le Groupe a pris en compte les données de patientes et patients en état critique de manière plus générale. Un caractère indirect supplémentaire a été pris en compte pour ces indicateurs et a conduit à une rétrogradation, potentiellement liée à des différences de population (les populations d'étude plus générales, en état critique, incluaient les populations présentant une lésion cérébrale traumatique ou une hépatopathie avancée, plutôt que le seul sepsis).

Les membres ont jugé que la recommandation s'appliquerait de manière similaire aux enfants, aux femmes enceintes et aux femmes allaitantes. La concordance avec les lignes directrices de l'OMS sur les liquides pédiatriques a été notée. Cette recommandation ne s'applique pas aux sujets atteints de la maladie à filovirus et souffrant d'un trauma ou d'une lésion cérébrale traumatique.

Le Groupe a mentionné l'essai randomisé par grappes récemment publié et non inclus dans la revue systématique qui a orienté cette recommandation. Cet essai a évalué l'utilisation d'une solution équilibrée par rapport à une solution saline normale en contexte hospitalier et n'a pas fait état de différence quant au critère de mortalité (critère de jugement principal) ; il a donc été jugé trop indirect pour être inclus dans les délibérations.

Recommandation conditionnelle en faveur de l'intervention – degré de certitude des données probantes : faible

Pour les patientes et patients présentant une maladie à filovirus suspectée ou confirmée et des signes cliniques de choc ou de trouble circulatoire, l'OMS propose la mesure en série du lactate, dans le cadre de l'évaluation de la perfusion, en vue d'affiner la prise en charge par voie intraveineuse.

- Cette recommandation s'applique aux enfants et aux adultes, y compris aux femmes enceintes.
- Le lactate est un marqueur d'hypoperfusion et, lorsqu'il est élevé, est associé à un pronostic défavorable.
- L'évaluation de la perfusion inclut également d'autres marqueurs cliniques tels que la pression artérielle, la fréquence cardiaque, la diurèse, l'état mental et le temps de recoloration capillaire.
- Il est possible d'exploiter les données de diminution du lactate au fil du temps pour conclure à l'efficacité du remplacement liquidien. Cependant, il convient de ne pas considérer la normalisation du lactate comme l'objectif.
- Il existe des situations où des niveaux élevés de lactate ne sont pas associés à une faible perfusion, notamment : une hépatopathie avancée lorsque le métabolisme du lactate est altéré, une activité musculaire excessive, une ischémie tissulaire focale ou régionale et certains médicaments (par exemple la metformine). En cas de taux élevé et persistant du lactate, il convient de rechercher d'autres affections co-existantes.
- Il est possible de mesurer le lactate dans le sang artériel, veineux ou capillaire. Le choix du type d'échantillon devra être conforme à la pratique locale et l'utilisation devra être cohérente, notamment lors de la comparaison des niveaux de lactate au fil du temps. En matière de précision, la ponction artérielle constitue l'étalon de référence, mais elle n'est pas encouragée en raison du risque de saignement dans le contexte de la maladie à filovirus.

Le Groupe a opté pour une recommandation conditionnelle, estimant que la majorité des patientes et patients choisiraient d'ajouter le lactate à l'évaluation de la perfusion, en raison de la réduction potentielle en matière de mortalité. Cependant, ces données probantes n'étaient pas suffisamment convaincantes pour justifier une utilisation universelle lorsque les limitations de ressources étaient importantes. Le Groupe a également relevé que le lactate n'est pas utilisé seul, mais plutôt dans le cadre d'une évaluation de la perfusion, où les mesures en série du lactate permettent d'orienter l'apport liquidien. En outre, la normalisation du lactate ne devra pas être considérée comme une cible. Dans les essais contrôlés randomisés inclus, les normes de soins étaient variables ; beaucoup utilisaient la pression artérielle moyenne, la surveillance de la pression veineuse centrale et d'autres outils pour surveiller la perfusion. Le Groupe a mentionné une incertitude quant à une application dans des situations de surveillance limitée en tant que « norme de soins ». Une attention particulière a été accordée à la mise en place de la meilleure surveillance possible compte tenu des ressources locales, en utilisant toutes les mesures disponibles, y compris les mesures de base telles que la pression artérielle, la fréquence cardiaque, la diurèse, l'état mental et le temps de recoloration capillaire (voir la recommandation suivante). Les membres ont également exprimé leur préoccupation quant à l'évaluation du lactate chez les sujets atteints de la maladie à filovirus et souffrant d'un trouble hépatique ; il convient de considérer ce contexte comme un domaine de recherche supplémentaire.

En outre, le lactate pourrait être utilisé pour identifier les patientes et patients à haut risque d'issue défavorable. Le Groupe a jugé que la recommandation devrait s'appliquer aux adultes, aux enfants et aux femmes enceintes compte tenu des associations similaires avec les résultats et du fait que le lactate est utilisé dans les définitions et outils de dépistage fréquemment utilisés pour le sepsis.

Les ECR ont principalement utilisé des mesures artérielles car elles sont considérées comme les plus précises, bien que d'autres modalités aient été autorisées. Pour la mise en œuvre sur le terrain, les mesures veineuses ou capillaires pourraient être plus fréquemment utilisées. Bien qu'un caractère indirect puisse être introduit, le Groupe a estimé que ce point était probablement négligeable, surtout lorsque le lactate est utilisé pour prendre en compte des changements dynamiques à l'échelle d'une patiente ou d'un patient.

Recommandation conditionnelle en faveur de l'intervention – degré de certitude des données probantes : faible

Pour les patientes et patients présentant une maladie à filovirus suspectée ou confirmée et des signes cliniques de choc ou de trouble circulatoire, l'OMS conseille d'utiliser le temps de recoloration capillaire, dans le cadre de l'évaluation de la perfusion, en vue d'orienter la prise en charge par voie intraveineuse.

- Cette recommandation s'applique aux enfants et aux adultes, y compris aux femmes enceintes.
- L'évaluation de la perfusion inclut également d'autres marqueurs tels que la pression artérielle, la fréquence cardiaque, la diurèse, l'état mental et le lactate.
- Il est également possible d'intégrer le temps de recoloration capillaire aux évaluations qui utilisent des technologies complémentaires telles que l'échographie, en fonction de la disponibilité, du niveau de formation et du niveau de soins.
- Dans le cadre de l'évaluation du temps de recoloration capillaire, l'utilisation de protocoles normalisés réduira la variabilité des mesures et augmentera la fiabilité et la précision.

Le Groupe a considéré l'étude ANDROMEDA-SHOCK-2 comme la source principale de données probantes. L'ajout de données issues d'un second essai contrôlé randomisé portant sur 30 sujets n'a apporté que peu d'informations. Le caractère direct des données probantes issues des sujets en état de choc septique a été jugé suffisant et le degré de certitude n'a donc pas subi de rétrogradation. Le Groupe a pris en compte les données relatives à des critères de jugement distincts (mortalité, jours sans soutien vital et durée de l'hospitalisation), bien qu'il s'agisse de critères secondaires dans l'essai. Le Groupe a noté que le critère principal (hiérarchique) de l'essai était associé à un degré de certitude faible quant à la supériorité du traitement par perfusion intraveineuse découlant du temps de recoloration capillaire (ratio 48,9 % par rapport à 42,1 %), la raison principale étant une différence en ce qui concerne les jours sans soutien vital. Dans des contextes à ressources limitées, les membres ont estimé que la réduction de la ventilation en particulier (capturée dans le critère des jours sans soutien vital), représentait un avantage important. Bien que l'on s'attende à ce que les critères précédents les reflètent, les inconvénients n'ont pas été répertoriés directement ; la mesure elle-même ne comporte pas d'inconvénients notables.

Compte tenu de la nature simple et peu coûteuse du test, ainsi que de la capacité universelle à l'effectuer, le Groupe a estimé que la formulation d'une recommandation conditionnelle pour le temps de recoloration capillaire était appropriée.

En pratique clinique, les membres ont noté que le temps de recoloration capillaire n'est pas utilisé seul : il convient de l'exploiter dans le cadre d'un protocole de réanimation qui inclut une évaluation de la perfusion au moyen de la pression artérielle, de la fréquence cardiaque, de la diurèse et du lactate, le cas échéant. Afin d'obtenir une vue d'ensemble de la suffisance circulatoire, il a été proposé que les cliniciennes et cliniciens intègrent également la mesure de l'oxymétrie de pouls. Les membres ont noté que le temps de recoloration capillaire était davantage établi dans le contexte de l'évaluation des enfants et que son utilisation était moins courante chez les adultes. Il serait donc avantageux de procéder à une normalisation de la mesure (voir Informations pratiques).

Le Groupe a estimé que la recommandation devrait s'appliquer à tous les groupes d'âge, compte tenu des données probantes des ECR issues d'une population adulte et jugées applicables aux enfants, ainsi que de son intégration comme norme de soins dans la pratique clinique pédiatrique.

Recommandation conditionnelle en faveur de l'intervention – degré de certitude des données probantes : faible

L'OMS conseille que, chez les patients présentant une infection à filovirus suspectée ou confirmée et souffrant d'un choc, et qui font l'objet d'une réanimation par administration de liquides par voie intraveineuse, le traitement par vasopresseurs soit instauré le plus tôt possible.

- Cette recommandation s'applique aux enfants et aux adultes, y compris aux femmes enceintes.
- Les vasopresseurs doivent être utilisés dans le cadre d'une stratégie de réanimation comprenant : une thérapie liquidienne intraveineuse appropriée ; une surveillance fréquente, notamment des arythmies cardiaques.
- Adapter individuellement la posologie en fonction de l'effet recherché (en ciblant la pression artérielle comme indicateur de la perfusion).
- Afin de minimiser les effets indésirables, utiliser la dose la plus faible possible pour obtenir l'effet recherché et arrêter les vasopresseurs dès qu'ils ne sont plus indiqués.

Cette recommandation ne s'applique pas aux états de choc causés principalement par une déshydratation sévère associée à des pertes gastro-intestinales persistantes, pour lesquels la réhydratation doit constituer le traitement principal de l'insuffisance circulatoire.

Recommandation forte en faveur de l'intervention – degré de certitude des données probantes : modéré

Pour les patientes et patients qui présentent une maladie à filovirus suspectée ou confirmée et qui nécessitent un traitement vasopresseur, l'OMS recommande l'utilisation de la noradrénaline plutôt que de la dopamine.

- Cette recommandation s'applique aux enfants et aux adultes, y compris aux femmes enceintes.
- Il convient d'utiliser les vasopresseurs dans le cadre d'une stratégie de réanimation englobant un traitement approprié par apport liquidien intraveineux et une surveillance fréquente, y compris le suivi de l'arythmie cardiaque.
- Personnaliser le dosage selon l'effet souhaité (en ciblant la pression artérielle comme indicateur de la perfusion).
- En vue de réduire au minimum les effets indésirables, utiliser la dose la plus faible possible pour l'effet souhaité et arrêter les vasopresseurs lorsqu'ils ne sont plus indiqués.

La recommandation forte formulée par le Groupe en faveur de la noradrénaline est motivée par les données probantes sur la réduction de la mortalité (critère de jugement critique), et appuyée par des taux plus faibles d'arythmies observées et d'événements indésirables graves. Le caractère direct des données probantes issues des essais sur le sepsis a été jugé suffisant ; le degré de certitude des données probantes n'a donc pas subi de rétrogradation. Dans sa décision, le Groupe a pris en compte le critère de l'arythmie. En effet, bien qu'il n'ait pas été considéré prioritaire dans un premier temps, il s'agit d'un marqueur important et pertinent en matière de sécurité/risque.

Aucune comparaison directe des essais contrôlés randomisés n'était disponible pour les populations pédiatriques. Le Groupe a estimé que cette recommandation était adaptée aux enfants et aux adultes, compte tenu de l'utilisation clinique courante de la noradrénaline ou de l'adrénaline comme vasopresseur de premier choix dans les essais récents portant sur un traitement précoce.

Bien qu'il n'existe pas de données directes sur une utilisation pendant la grossesse, les membres ont considéré que l'avantage indéniable de la noradrénaline en matière de mortalité s'appliquerait probablement aussi aux femmes enceintes. Cette position est cohérente avec les principes de la pratique obstétricale dans le contexte des maladies graves : optimiser la circulation maternelle est la stratégie la plus efficace pour préserver la perfusion fœtale, et les retards dans la mise en route d'un traitement vasopresseur pourraient aggraver l'issue, tant pour la mère que pour le fœtus.

Recommandation conditionnelle en faveur de l'intervention – degré de certitude des données probantes : très faible

Pour les patientes et patients qui présentent une maladie à filovirus suspectée ou confirmée et qui nécessitent un traitement vasopresseur, l'OMS conseille l'utilisation de la noradrénaline plutôt que de l'adrénaline.

- Cette recommandation s'applique aux enfants et aux adultes, y compris aux femmes enceintes.
- Le choix entre la noradrénaline ou l'adrénaline peut dépendre de la disponibilité et des pratiques locales.
- Pour certains sujets, par exemple les personnes souffrant d'insuffisance cardiaque systolique, l'adrénaline pourrait être préférable à la noradrénaline seule.
- Il convient d'utiliser les vasopresseurs dans le cadre d'une stratégie de réanimation englobant un traitement approprié par apport liquidien et une surveillance fréquente, y compris la détection précoce d'une arythmie.
- Personnaliser le dosage selon l'effet souhaité (amélioration de la perfusion).
- En vue de réduire au minimum les effets indésirables, utiliser la dose la plus faible possible pour l'effet souhaité et arrêter les vasopresseurs lorsqu'ils ne sont plus indiqués.

Le Groupe a estimé qu'une recommandation conditionnelle en faveur de la noradrénaline plutôt que de l'adrénaline garantirait une utilisation plus cohérente du vasopresseur le plus efficace (selon les données probantes), tout en laissant une marge de manœuvre aux cliniciennes et cliniciens pour utiliser l'adrénaline dans les contextes où la noradrénaline n'est pas disponible, ou lorsqu'une insuffisance cardiaque pourrait justifier d'utiliser prioritairement l'adrénaline.

Dans sa décision, le Groupe a pris en compte le critère de l'arythmie. En effet, bien qu'il n'ait pas été considéré prioritaire dans un premier temps, il s'agit d'un marqueur important et pertinent en matière de sécurité/risque. Les estimations du risque absolu de mortalité ont été extraites de la méta-analyse initiale et n'ont pas été corrigées pour différents risques de référence, compte tenu des intervalles de confiance très larges.

Des considérations théoriques sur le risque ont été prises en compte dans le cadre de l'utilisation de l'adrénaline car son activité antagoniste β -1 supérieure peut conduire à une arythmogénicité accrue et à une vasoconstriction splanchnique. Le Groupe a également mentionné la recommandation forte qu'il a formulée (décrite précédemment) concernant l'utilisation de la noradrénaline plutôt que de la dopamine, sur la base de données probantes dont le degré de certitude était modéré en matière de mortalité ; cette recommandation pourrait permettre d'augmenter sa disponibilité et son utilisation de manière générale. Les membres ont relevé que les essais incluant la noradrénaline en tant que comparateur incluaient également des patientes et patients ayant reçu des agents inotropes concomitants. Cependant, aucun effet d'interaction de sous-groupe pour la noradrénaline seule a été observé, comparativement à la noradrénaline avec un autre agent inotrope (par exemple la dopexamine), $p = 0,56$. Ces données concordent avec une méta-analyse en réseau qui estimait l'odds ratio de la mortalité pour la noradrénaline (+/- dobutamine) par rapport à l'adrénaline, soit 0,87 (IC à 95 % : 0,67-1,12).

Le GDG a estimé que cette recommandation devrait s'appliquer aux adultes et aux enfants. Cette position est étayée par les données d'un ECR de 67 enfants, qui semblent indiquer l'absence de différence, en matière de mortalité, entre le traitement par noradrénaline (+dobutamine) et le traitement par adrénaline (RR 0,59 ; IC à 95 % : 0,28-1,25) ; la puissance de l'essai était cependant insuffisante pour pouvoir éclairer avec certitude sur les avantages ou les inconvénients.

Bien qu'il n'existait pas de données directes sur l'utilisation pendant la grossesse, le Groupe a estimé qu'il n'y avait aucune raison de croire que le choix portant sur l'adrénaline ou la dopamine chez les femmes enceintes avec une infection potentiellement mortelle présenterait un rapport avantage/inconvénient différent de celui de la population plus large (ce qui est confirmé par la pratique clinique courante).

Recommandation conditionnelle en faveur de l'intervention – degré de certitude des données probantes : très faible

Pour les patientes et patients atteints de la maladie à filovirus et qui nécessitent l'instauration d'un traitement vasopresseur, l'OMS conseille d'utiliser un cathéter veineux périphérique plutôt qu'un cathéter veineux central.

- Cette recommandation s'applique aux enfants et aux adultes, y compris aux femmes enceintes.
- L'administration par voie intraveineuse périphérique évite le délai associé au cathétérisme veineux central et permet un traitement plus rapide, susceptible d'améliorer l'issue.
- Pour le cathéter intraveineux périphérique, utiliser le plus gros calibre possible en vue de réduire au minimum le risque d'extravasation.
- Il est nécessaire de procéder à une surveillance systématique et fréquente du site intraveineux.
- Une transition vers l'administration par voie intraveineuse centrale devra être anticipée.

Les données probantes proviennent d'une revue systématique commandée par l'OMS et publiée dans le cadre de ces lignes directrices.

Le Groupe a formulé une recommandation conditionnelle, d'une part sur la base de l'expérience de terrain de ses membres en ce qui concerne un temps de mise en route du traitement plus court avec l'administration par voie périphérique, et d'autre part en fonction de données probantes selon lesquelles un traitement vasopresseur précoce était susceptible d'améliorer grandement l'issue (voir la recommandation relative au traitement vasopresseur précoce).

Le Groupe a estimé que l'instauration d'un traitement vasopresseur par voie périphérique plutôt que par voie centrale serait plus aisée, plus rapide et conduirait à une administration plus rapide de médicaments d'importance vitale (voir la recommandation relative à la noradrénaline). Des préoccupations ont été exprimées au sujet du risque d'extravasation dans le cadre de l'administration par voie périphérique, lequel nécessite donc une surveillance minutieuse et une action clinique immédiate pour prévenir les préjudices graves. La méta-analyse des cohortes observationnelles semble indiquer que cet événement se produit à un taux de 14 pour 1 000 (IC à 95 % : 7,2-23,2), sur la base de 93 événements pour 4 613 participantes et participants dans 19 études. Le Groupe a indiqué que l'administration par voie intraveineuse périphérique constituait une passerelle vers la pose nécessaire d'un cathéter veineux central.

Recommandation forte en faveur de l'intervention – degré de certitude des données probantes : modéré

Pour les patientes et patients présentant une maladie à filovirus suspectée ou confirmée et qui nécessitent la pose d'un accès veineux central, l'OMS recommande une pose par guidage échographique plutôt qu'un autre type de pose.

- Cette recommandation s'applique aux enfants et aux adultes, y compris aux femmes enceintes.
- La pose d'un cathéter veineux central par guidage échographique suppose la présence d'un personnel de santé formé, ainsi que la disponibilité du matériel et des fournitures essentiels.
- Veiller à ce que des mesures de lutte anti-infectieuse appropriées soient mises en place pour réduire le risque d'infection lors du guidage échographique.
- Surveiller systématiquement le site du cathéter.
- Retirer le cathéter lorsqu'il n'est plus nécessaire.

Les membres ont estimé que la sécurité des patientes et patients pouvait être affectée par les autres recommandations concernant l'utilisation des vasopresseurs. En particulier, et bien qu'une administration périphérique initiale soit privilégiée, le cathétérisme veineux central serait plus courant si toutes les recommandations étaient appliquées. Aussi le Groupe a-t-il examiné les données probantes concernant les modalités de pose du cathéter veineux central, qui pourraient atténuer les risques.

Les données ont été tirées d'une revue systématique des approches échographiques par rapport aux approches de référence pour la canulation de la veine jugulaire, qui faisait état de plusieurs motifs d'insertion. Il a été considéré que les données probantes étaient directement liées aux patientes et patients atteints de la maladie à filovirus, car on s'attendait à ce que les risques et les avantages de l'acte soient similaires. Le Groupe a relevé que le saignement, dans le contexte du syndrome hémorragique associé au filovirus, pourrait aggraver l'issue liée à la ponction artérielle. Bien que les critères de jugement n'aient pas fait l'objet d'une hiérarchisation, le GDG est préalablement convenu que les événements indésirables graves (EIG) constituaient un critère de jugement critique. Dans le contexte de la canulation veineuse, les EIG comprenaient la ponction artérielle, le pneumothorax et l'emphysème sous-cutané sévère.

Les membres ont décidé à l'unanimité qu'une recommandation pour une pose par guidage échographique soit formulée. Une minorité, invoquant des préoccupations en matière de faisabilité, estimait que la recommandation devait être conditionnelle, malgré un degré de certitude modéré des données probantes en ce qui concerne les avantages. Cependant, après délibération, un vote a été organisé, au cours duquel 80 % des membres ont opté pour une recommandation forte. Les justifications sont les suivantes : le risque élevé d'issue catastrophique si une hémorragie ou un pneumothorax survenait dans un contexte où les patientes et patients présentent un risque accru de saignement, et dans un environnement complexe où les ressources sont limitées et où il est nécessaire de réaliser les actes avec un équipement de protection individuelle complet. Le Groupe a estimé que l'échographie et les fournitures associées à la lutte anti-infectieuse étaient essentielles ; il a mentionné que la présence d'un personnel qualifié et l'existence de protocoles de sécurité étaient également obligatoires.

Recommandation conditionnelle en faveur de l'intervention – degré de certitude des données probantes : faible

Pour les patientes et patients présentant une maladie à filovirus confirmée et en cas de suspicion de sepsis ou de co-infection bactérienne, l'OMS propose l'administration d'un traitement antibiotique présomptif à large spectre.

- Cette recommandation s'applique aux enfants et aux adultes, y compris aux femmes enceintes.
- Le traitement antibiotique présomptif fait référence à l'administration d'antibiotiques lorsqu'il y a suspicion clinique de sepsis et/ou de co-infection bactérienne.
- Il convient que l'administration d'antibiotiques par voie intraveineuse ait lieu sans délai, en cas de suspicion de sepsis ou de choc.
- Dans la mesure du possible, le choix des antibiotiques se fera en fonction des profils locaux de résistance aux antimicrobiens.
- Cette recommandation ne s'applique pas aux patientes et patients présentant un faible risque de co-infection bactérienne. Pour ces derniers, il convient de ne pas administrer d'antibiotiques de manière systématique, mais plutôt de procéder à une surveillance et à une réévaluation de la présence effective d'une infection bactérienne ou d'un sepsis en vue d'orienter le traitement antibiotique.
- Utiliser les outils de laboratoire disponibles, y compris la bactériologie et les biomarqueurs, pour guider le diagnostic microbiologique et le traitement antimicrobien, et établir une désescalade thérapeutique appropriée, dans la mesure du possible.

Les données probantes proviennent d'une revue systématique commandée par l'OMS et publiée dans le cadre de ces lignes directrices.

Le Groupe a déterminé que, chez les patientes et patients présentant une maladie à filovirus confirmée, le traitement antibiotique présomptif (c'est-à-dire l'administration sans preuve clinique objective d'une infection bactérienne) pourrait réduire la mortalité. Selon les membres, la principale manifestation clinique de la forme grave de la maladie à filovirus est un syndrome évocateur d'un sepsis, et la co-infection bactérienne ne peut être exclue. On émet également l'hypothèse d'une translocation bactérienne accrue depuis le tractus gastro-intestinal, comme on le constate dans d'autres maladies graves. Compte tenu du taux de mortalité élevé préexistant dans une population atteinte d'une forme grave de la maladie et du grand bénéfice attendu des antibiotiques en cas d'infection bactérienne non diagnostiquée, le Groupe a estimé que l'avantage, à l'échelle d'une patiente ou d'un patient, l'emportait probablement sur les risques pour la population (en matière de résistance aux antimicrobiens) et sur les préoccupations individuelles en matière d'événements indésirables.

Selon le Groupe, la résistance aux antimicrobiens constitue effectivement une menace mondiale, mais le nombre de patientes et patients auxquels pourrait s'appliquer cette recommandation est très limité et leur contribution au phénomène de résistance serait négligeable. Cependant, les bonnes pratiques supposent que l'agent antimicrobien le plus approprié soit utilisé durant un laps de temps le plus court possible.

Pour les formes bénignes de la maladie à filovirus, et lorsque les sujets ne présentent aucun signe de co-infection bactérienne, le Groupe a remis en question l'avantage de l'intervention et a signalé que les risques liés à des événements indésirables sévères et à la résistance aux antimicrobiens demeuraient. Il convient de ne pas appliquer cette recommandation dans ces circonstances. Le Groupe a indiqué qu'il n'existait aucun outil officiel établissant la probabilité d'une infection bactérienne préalablement à un test, et que le médecin devrait prendre une décision sur la base d'une évaluation personnalisée du risque.

Le Groupe a jugé que la même justification s'appliquerait aux enfants et aux adultes, y compris aux femmes enceintes.

La recommandation s'applique au moment de l'admission dans l'unité d'isolement pour les cas suspects et/ou au sein du centre de traitement du filovirus. L'éventualité d'une infection nosocomiale ultérieure, avec une apparition plus tardive et d'autres étiologies bactériennes, nécessite une approche individualisée. Le Groupe a mentionné que l'étiologie par culture bactérienne et antibiogramme constituait une pratique exemplaire en dehors des flambées épidémiques, mais que ces techniques sont rarement disponibles dans les centres de traitement du filovirus.

Recommandation conditionnelle en défaveur de l'intervention – degré de certitude des données probantes : très faible**L'OMS déconseille l'emploi de l'acide tranexamique chez les patientes et patients présentant une maladie à filovirus confirmée et une hémorragie.**

- Cette recommandation s'applique aux adultes et aux enfants atteints de la maladie à filovirus et qui présentent des saignements aux sites intraveineux, du tractus gastro-intestinal et de la muqueuse buccale.
- Elle ne s'applique pas aux patientes et patients atteints de la maladie à filovirus et qui saignent en raison d'une affection pour laquelle l'acide tranexamique présente un bénéfice prouvé, comme une hémorragie du post-partum, un saignement chirurgical ou un trauma.

Il existe un besoin manifeste de mener davantage d'études biologiques pour comprendre les mécanismes physiopathologiques des hémorragies dans la maladie à filovirus. Le Groupe est convenu que la compréhension actuelle du mécanisme à partir du sepsis, selon lequel la coagulation intravasculaire disséminée contribue dans une large mesure à l'altération de l'hémostase, soulève de fortes inquiétudes quant aux risques associés à l'acide tranexamique. Il a été considéré que la source de données probantes parallèle la plus proche provenait du traitement différé des sujets après un trauma, car la coagulation intravasculaire disséminée est probablement un processus physiopathologique courant. Ici, l'acide tranexamique est associé à une mortalité accrue.

Une autre préoccupation a été exprimée concernant le faible degré de certitude des données probantes relatives à un risque accru de thrombose chez les patientes et patients souffrant d'hémorragie gastro-intestinale. Ces inconvénients potentiels, en l'absence de données probantes directes sur les avantages, ont conduit le Groupe à formuler une recommandation conditionnelle en défaveur de l'acide tranexamique.

Cette recommandation s'applique aux enfants et aux adultes, ainsi qu'aux femmes enceintes qui ne présentent pas d'hémorragie du post-partum. Le Groupe a décidé de formuler une recommandation distincte pour une utilisation dans le cadre de l'hémorragie du post-partum.

Recommandation conditionnelle en faveur de l'intervention – degré de certitude des données probantes : faible

L'OMS conseille l'utilisation de l'acide tranexamique chez les patientes présentant une maladie à filovirus confirmée et une hémorragie du post-partum.

- Adopter des protocoles de soins standard pour l'hémorragie du post-partum, y compris un agent utérotonique (l'oxytocine est préférable, lorsqu'elle est disponible).
- Il convient d'administrer l'acide tranexamique par voie intraveineuse dans les 3 heures suivant la naissance.

Compte tenu de l'avantage avéré en cas d'hémorragie du post-partum, le Groupe a estimé que l'instauration d'un traitement par acide tranexamique dans cette sous-population spécifique serait probablement bénéfique. Bien que le risque théorique de préjudice lié à la coagulation intravasculaire disséminée subsiste, celui-ci n'est pas quantifiable et on dispose en outre d'un solide ensemble plus large de données probantes en faveur d'un avantage en cas d'hémorragie du post-partum. Le Groupe a estimé que le traitement devrait donc être instauré conformément aux recommandations de l'OMS. Pour les personnes atteintes de la maladie à filovirus, le Groupe a considéré qu'il existait un caractère indirect des données probantes issues de la population générale, ce qui a entraîné une rétrogradation du degré de certitude (sur le degré faible) et une recommandation conditionnelle consécutive.

Recommandation forte en faveur de l'intervention – degré de certitude des données probantes : modéré

L'OMS recommande que les personnes qui ont survécu à la maladie à filovirus/qui se sont rétablies de la maladie à filovirus se voient proposer un suivi structuré après la sortie du lieu de soins.

- Cette recommandation s'applique aux enfants et aux adultes.
- Le suivi structuré inclut l'accès à des soins gratuits et complets pour évaluer et traiter des complications telles que les symptômes de santé mentale, les maladies oculaires et la persistance du virus dans les sites sanctuaires, ainsi que la garantie d'un accouchement en toute sécurité pour les femmes enceintes en rétablissement.

Le Groupe a initialement examiné les données probantes incluant la prévalence des symptômes et les anomalies médicales après une infection à filovirus. Cependant, en l'absence d'informations sur les interventions susceptibles de présenter un avantage, le degré de certitude des données probantes a été jugé faible. Des travaux supplémentaires ont donc été entrepris pour identifier plusieurs domaines de données probantes associées présentant un potentiel d'amélioration significative des critères importants pour les patientes et patients. Le Groupe est convenu que la complexité des soins requis, ainsi que les taux élevés de symptômes chroniques post-infection, seraient peu susceptibles d'être pris en charge de manière adéquate au sein des systèmes de santé existants sans directives spécifiques. Les interventions seraient mises en œuvre de manière la plus efficace sous forme d'un ensemble d'évaluations et de traitements dans les centres de suivi post-infection à filovirus ; cet ensemble pourrait s'intégrer aux services de santé primaires et potentiellement conduire à un renforcement local des capacités.

En matière de données probantes établissant un lien entre l'incidence de la maladie et les résultats positifs du traitement, les éléments suivants ont été identifiés :

1. Le dépistage de la dépression, avec l'instauration ultérieure d'un traitement par inhibiteurs sélectifs de la recapture de la sérotonine (ISRS), dont il a été démontré qu'il améliore les critères importants pour les patientes et patients en matière de santé mentale. Le critère de dépression était considéré critique, car « éviter la stigmatisation et les problèmes de santé mentale » présentait un score médian de 8/9 lors d'un exercice de hiérarchisation des priorités. Le Groupe a estimé que 25 % au plus de ces 150 pour 1 000 survivantes et survivants atteints de dépression recevraient un traitement (c'est-à-dire que les symptômes dépressifs seraient reconnus et traités si les approches en matière de soins habituels étaient adoptées, soit un recours réactif aux soins, axé sur la patiente/le patient). Cette donnée concorde avec les chiffres déclarés par l'OMS, à savoir entre 76 % et 85 % des personnes atteintes de troubles mentaux graves ne reçoivent aucun traitement dans les pays à revenu faible ou intermédiaire. Sur la base de l'estimation prudente (76 %), le nombre attendu de cas supplémentaires de dépression traitée si un suivi structuré était mis en œuvre serait de 16/1 000, et dépasserait le seuil de différence importante d'effet de 15/1 000.
2. Réduction de la transmission ultérieure liée à l'activité sexuelle, au moyen de conseils structurés sur les pratiques sexuelles sans risque et de tests réguliers de sperme jusqu'à la vérification de la clairance virale. La persistance virale a été documentée dans la maladie à virus Soudan et dans la maladie à virus Ebola, où le délai médian pour une PCR négative était de 204 jours et où la réduction du risque dans les pratiques sexuelles est susceptible de diminuer la transmission. L'absence d'un tel programme pourrait avoir des conséquences catastrophiques sur la réapparition de l'infection et aboutir à une nouvelle flambée épidémique.
3. Identification d'une perte de vision dont on sait qu'elle survient à des taux élevés à la suite d'une uvéite, après une infection à filovirus. Un traitement spécialisé serait nécessaire, mais l'absence de programme de dépistage signifierait nécessairement que les patientes et patients n'ont reçu aucun traitement approprié (données non présentées).

Les risques liés à l'établissement de cet environnement de soins structurés ont été jugés minimes, à condition que les coûts importants (directs ou indirects) ne soient pas supportés par les patientes et patients ou leurs familles, et que la stigmatisation soit réduite.

Organisation mondiale de la Santé
20 avenue Appia
1211 Genève 27
Suisse